

Usted tiene los datos. Nosotros, el método.

La mayoría de los proyectos no se frenan por falta de datos, sino porque nadie definió la pregunta antes de recogerlos. Entramos ahí: convertimos una base clínica o genómica en una respuesta defendible, con cada decisión metodológica escrita y el análisis de principio a fin. Si el estudio todavía no existe, lo diseñamos con usted desde el protocolo.

Qué hacemos

Somos una firma pequeña de análisis de datos biomédicos. Hacemos bioestadística, epidemiología, bioinformática y diseño de estudios. Trabajamos con grupos de investigación, hospitales, laboratorios de genética y empresas.

- No hacemos secuenciación ni trabajo de laboratorio.
- No emitimos diagnóstico ni conducta médica. Nuestro trabajo es de investigación y análisis.
- Firmamos confidencialidad siempre, y acuerdo de tratamiento de datos cuando el proyecto tiene datos de personas.

Cómo trabajamos

01 Revisión inicial

Miramos su base o su protocolo durante una hora y le decimos por escrito qué encontramos. Sin costo.

02 Cotización

Le enviamos alcance, entregables, fechas y precio.

03 Recepción de datos

Nos envía los datos por canal seguro con el checklist completo. Si falta algo, el cronograma no arranca.

04 Control de calidad

Revisamos qué la calidad de los datos que llegaron y le decimos si seguimos, si hay que ajustar o si hay que devolverse.

05 Análisis

Ejecutamos el plan y dejamos registrada cada decisión metodológica.

06 Revisión con usted

Usted lee y comenta. Van una o dos rondas incluidas.

07 Cierre

Acta de aceptación y borrado de los datos en la fecha que hayamos pactado.

Con cada entrega se anexa el reporte ejecutivo y el técnico, las tablas y figuras listas para el manuscrito, y el código en R o Python con las versiones fijadas.

Servicios

Primero revisamos su caso y después cotizamos, porque el valor depende del tamaño de la base, de cómo lleguen los datos y de qué tan enredado esté el diseño. Adivinar eso por adelantado no le sirve a nadie. Los plazos sí los puede estimar desde ya.

Asesoría metodológica y diseño de estudios

SERVICIO	QUÉ RECIBE	PLAZO ESTIMADO
Diseño de estudio y protocolo	Pregunta y endpoint definidos, elección del diseño, criterios de inclusión y plan para los datos que falten	5–15 días
Plan de análisis estadístico	Documento SAP completo, con la justificación metodológica y el anexo para el comité de ética	5–15 días
Cálculo de tamaño de muestra	El cálculo, los supuestos, escenarios de sensibilidad y el párrafo redactado para el protocolo	3–7 días
Apoyo a convocatoria	El componente de análisis de la propuesta, con cronograma y presupuesto técnico	5–10 días

Bioestadística y epidemiología clínica

Estudios observacionales, registros institucionales y ensayos.

SERVICIO	QUÉ RECIBE	PLAZO ESTIMADO
Regresión logística o lineal	Modelo, diagnóstico de supuestos, OR o β con IC95%, tablas y figuras	5–15 días
Supervivencia	Curvas Kaplan-Meier, HR con IC95% y el chequeo de riesgos proporcionales	2–5 semanas
Análisis de registros	Definición de la cohorte, tasas e incidencias, estratificación y ajuste por confusores	2–5 semanas
Modelos avanzados	Mixtos, GEE o multinomial. Modelo, validación e interpretación	2–5 semanas
Inferencia causal	Propensity score o IPTW: balance, efecto estimado y análisis de sensibilidad	3–6 semanas

Curaduría y análisis de datos

SERVICIO	QUÉ RECIBE	PLAZO ESTIMADO
Limpieza, EDA y diccionario	Validación de calidad, diccionario de variables, base depurada y tablas descriptivas	5–12 días

SERVICIO	QUÉ RECIBE	PLAZO ESTIMADO
Revisión para publicación	Tabla 1 y tablas de resultados, figuras a resolución de revista y los métodos redactados	5–15 días
EDA de datos no clínicos	Limpieza, ingeniería de variables, visualizaciones y los hallazgos con recomendaciones	5–15 días
Auditoría de reproducibilidad	Revisión del código y de las decisiones, reejecución e informe de discrepancias	5–10 días

Formación aplicada

SERVICIO	QUÉ RECIBE	PLAZO ESTIMADO
Análisis de datos clínicos en R por cohorte	Manejo de datos, tablas descriptivas, regresión, supervivencia y reportes reproducibles	16–24 h
Python para datos biomédicos por cohorte	pandas, visualización, control de versiones y buenas prácticas de análisis	16–24 h
Bioinformática aplicada por cohorte	Del FASTQ al resultado: control de calidad, pipelines nf-core y lectura de salidas	24–32 h

Genómica, transcriptómica y modelos

SERVICIO	QUÉ RECIBE	PLAZO ESTIMADO
RNA-seq bulk	QC, cuantificación, PCA, expresión diferencial y enriquecimiento funcional	2–5 semanas
Reanálisis de datos públicos	Curaduría del set de GEO o SRA, reprocesamiento versionado y comparación con el estudio original	5–15 días
Exoma germinal una muestra	QC, BAM/CRAM, VCF, anotación en tabla y resumen ejecutivo	7–12 días
PCA y proporciones de ancestría	QC de genotipos, PCA, gráficos y tabla de proporciones	7–15 días
ADMIXTURE con barrido de K	Búsqueda de K, error de validación cruzada y gráficos por individuo y grupo	10–20 días
Modelo de machine learning prueba de concepto	Pipeline, validación cruzada, métricas, interpretabilidad y notebook reproducible	4–10 semanas

También hacemos scRNA-seq, genoma completo, exoma o genoma somático tumor-normal, transcriptómica espacial, desarrollo de API y puesta en producción. En esos casos revisamos factibilidad antes de comprometer una fecha.

Qué necesitamos para empezar

Datos clínicos y epidemiológicos

- Base en CSV, Excel o SQL, con identificador único por paciente o episodio.
- Diccionario de variables, o definición escrita de cada campo y su codificación.
- Definición exacta del endpoint y, si aplica, reglas de censura.
- Criterios de inclusión y exclusión, y variable de exposición o tratamiento.
- Fechas en formato consistente y código explícito de valores perdidos.

Datos genómicos y transcriptómicos

- FASTQ o BAM/CRAM y, si aplica, BED del target e información del panel.
- Sample sheet con IDs consistentes, pareamiento y batches identificados.
- Diseño experimental, grupos de comparación y covariables.
- Genoma de referencia y versión de anotación acordados.

En todos los casos

- Confirmación escrita de que cuenta con la base legal y los consentimientos para compartir los datos, y el aval del comité de ética cuando aplique.
- Canal seguro de intercambio: enlace con expiración, SFTP o repositorio cifrado.

Datos y seguridad

Los datos viajan cifrados y se guardan cifrados. El acceso es por roles y con doble factor. Queda registro de quién hizo qué. Los ambientes de trabajo están separados y hay copias de respaldo. Al cerrar borramos, en la fecha que hayamos pactado.

Cuando el proyecto toca datos personales dejamos por escrito quién es Responsable y quién Encargado, como lo pide la Ley 1581 de 2012. Los datos de salud y los genéticos son datos sensibles y se manejan con reglas más estrictas.

Términos

- Cotizamos después de la revisión inicial.
- Se paga 50% al arrancar y 50% contra entrega. En proyectos de más de ocho semanas, por hitos.
- Van incluidas una o dos rondas de ajustes sobre el reporte.
- No incluye resecuenciación, licencias de terceros ni interpretación clínica regulada.
- Si el alcance cambia después de arrancar, eso se cotiza aparte.

Empecemos por una revisión sin costo. Miramos su base o su protocolo durante una hora y le decimos por escrito qué encontramos. De ahí sale la cotización.

gerencia@h-corpus.com